

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR : 375.1/I-KEP/DIR/VII/2026**

**TENTANG
PENETAPAN DOKTER SPESIALIS ANESTESI YANG KOMPETEN UNTUK MEMBERIKAN SEDASI
MODERAT DAN DALAM**

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

- Menimbang : a. Bahwa pelayanan sedasi moderat dan sedasi dalam merupakan pelayanan berisiko yang harus diberikan oleh tenaga medis yang memiliki kompetensi dan kewenangan klinis sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa untuk menjamin mutu dan keselamatan pasien, perlu ditetapkan dokter yang kompeten dan berwenang dalam memberikan pelayanan sedasi moderat dan sedasi dalam di RS Prima Husada Malang;
- c. bahwa berdasarkan hasil kredensial, penilaian kompetensi, kewenangan klinis, dan/atau penugasan klinis, dokter yang namanya tercantum dalam keputusan ini dinyatakan memenuhi persyaratan untuk memberikan pelayanan sedasi sesuai kewenangannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 519/MENKES/PER/III/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Anastesi dan Terapi Intensif di Rumah Sakit
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1541/2022 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Anesthesiologi dan Terapi Intensif;
5. Keputusan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 390/I-KEP/DIR/V/2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada;
6. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 263/DPM/I-KEP/DIR/II/2025 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA TENTANG
PENETAPAN DOKTER SPESIALIS ANESTESI YANG KOMPETEN
UNTUK MEMBERIKAN SEDASI MODERAT DAN DALAM**
- Kedua : Menetapkan dokter berikut sebagai dokter yang kompeten dan berwenang memberikan pelayanan sedasi moderat dan sedasi dalam di RS Prima Husada Malang:
1. dr. Arief Heru Wicaksono, Sp.An.
 2. dr. Robby, Sp. An
 3. dr. Deny Prasetyo, Sp. An.



Ketiga : Rincian kompetensi, kewenangan, area pelayanan, persyaratan pelaksanaan, serta ketentuan pemantauan pasien dalam pelayanan sedasi moderat dan sedasi dalam tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 14 Juli 2026
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Resti Lestantini, M. Kes

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA MALANG
NOMOR 375.1/I-KEP/DIR/VII/2026
TENTANG PENETAPAN DOKTER
SPECIALIS ANESTESI YANG KOMPETEN
UNTUK MEMBERIKAN SEDASI MODERAT
DAN DALAM

RINCIAN KOMPETENSI DAN KEWENANGAN PELAYANAN SEDASI MODERAT DAN SEDASI DALAM

A. DOKTER YANG DITETAPKAN

1. dr. Arief Heru Wicaksono, Sp.An.
2. dr. Robby, Sp. An
3. dr. Deny Prasetyo, Sp. An.

Dokter tersebut dinyatakan kompeten dan berwenang memberikan pelayanan sedasi moderat dan sedasi dalam sesuai dengan kewenangan klinis dan penugasan klinis masing-masing.

B. AREA PELAYANAN SEDASI

Sedasi moderat dan sedasi dalam dapat dilakukan pada area rumah sakit yang telah ditetapkan dan memenuhi persyaratan keselamatan pasien, meliputi:

1. kamar operasi;
2. ruang tindakan/prosedur diagnostik dan terapeutik;
3. instalasi gawat darurat apabila terdapat indikasi medis;
4. ruang perawatan intensif apabila terdapat indikasi medis; dan
5. area pelayanan lain yang telah dinilai dan ditetapkan oleh rumah sakit sebagai area yang memenuhi persyaratan untuk pelaksanaan sedasi.

Setiap area pelayanan sedasi harus memiliki kesiapan sumber daya manusia, obat-obatan, peralatan pemantauan, peralatan pengelolaan jalan napas, oksigen, dan fasilitas resusitasi yang sesuai.

C. KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI DOKTER PEMBERI SEDASI

Dokter yang memberikan sedasi moderat dan sedasi dalam harus:

1. memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik yang masih berlaku sesuai ketentuan;
2. telah melalui proses kredensial dan memiliki kewenangan klinis serta penugasan klinis yang sesuai;
3. mampu melakukan penilaian pasien sebelum sedasi;
4. mampu menentukan tingkat dan rencana sedasi yang sesuai;
5. memahami farmakologi, dosis, efek samping, interaksi, dan komplikasi obat sedasi;
6. mampu melakukan pemantauan pasien selama dan setelah sedasi;
7. mampu mengenali perubahan tingkat sedasi yang lebih dalam dari yang direncanakan;
8. mampu melakukan pengelolaan jalan napas dan ventilasi;
9. mampu melakukan tindakan resusitasi sesuai kebutuhan pasien;
10. mampu mengenali dan menangani komplikasi akibat sedasi; dan
11. mampu menentukan kriteria pemulihan dan kelayakan pasien untuk dipindahkan atau dipulangkan sesuai kondisi klinis.

D. PERSETUJUAN MEDIS (INFORMED CONSENT)

1. Sebelum pelaksanaan tindakan, pasien dan/atau pihak yang berhak memberikan persetujuan wajib memperoleh penjelasan mengenai prosedur yang akan dilakukan dan pemberian sedasi.
2. Penjelasan sekurang-kurangnya mencakup tujuan, manfaat, risiko, kemungkinan komplikasi, dan alternatif yang tersedia.
3. Persetujuan tindakan untuk prosedur dan pemberian sedasi harus didokumentasikan sesuai ketentuan rumah sakit.
4. Dalam keadaan gawat darurat, pelaksanaan tindakan mengikuti ketentuan peraturan

perundang-undangan dan kebijakan rumah sakit yang berlaku.

E. PERTIMBANGAN BERDASARKAN POPULASI PASIEN

Pelaksanaan sedasi wajib mempertimbangkan perbedaan kebutuhan dan risiko pada setiap populasi pasien, meliputi:

1. **Pasien anak**, dengan memperhatikan usia, berat badan, perkembangan fisiologis, perhitungan dosis, risiko gangguan jalan napas, dan kebutuhan peralatan pediatrik.
2. **Pasien dewasa**, dengan memperhatikan kondisi klinis, status fisik, penyakit penyerta, jenis tindakan, dan respons terhadap obat sedasi.
3. **Pasien geriatri**, dengan memperhatikan perubahan fisiologis akibat usia, penyakit penyerta, penggunaan beberapa jenis obat, peningkatan sensitivitas terhadap obat sedasi, dan peningkatan risiko komplikasi.
4. **Pasien dengan kondisi khusus**, termasuk pasien dengan obesitas, kehamilan, gangguan jalan napas, gangguan fungsi organ, atau kondisi lain yang meningkatkan risiko sedasi.

F. PERALATAN MEDIS, OBAT, DAN BAHAN

Pelayanan sedasi moderat dan sedasi dalam harus didukung oleh peralatan, obat, dan bahan yang sesuai dengan usia, ukuran tubuh, kondisi klinis, dan populasi pasien, sekurang-kurangnya meliputi:

1. alat pemantauan tekanan darah;
2. pulse oximeter;
3. alat pemantauan jantung sesuai indikasi;
4. sumber dan alat pemberian oksigen;
5. suction;
6. peralatan pengelolaan jalan napas dan ventilasi;
7. peralatan resusitasi;
8. obat sedasi dan obat emergensi;
9. cairan dan akses intravena sesuai kebutuhan; dan
10. peralatan khusus sesuai populasi pasien, termasuk ukuran peralatan yang sesuai untuk pasien anak.

G. PEMANTAUAN PASIEN

1. Sebelum Sedasi

Dilakukan penilaian dan dokumentasi sekurang-kurangnya terhadap:

- a. identitas pasien;
- b. riwayat kesehatan dan penyakit penyerta;
- c. riwayat alergi;
- d. riwayat penggunaan obat;
- e. riwayat sedasi atau anestesi sebelumnya;
- f. penilaian jalan napas;
- g. tanda-tanda vital; dan
- h. kondisi lain yang dapat meningkatkan risiko sedasi.

2. Selama Sedasi

- a. Pasien dipantau secara berkesinambungan sesuai tingkat sedasi dan kondisi klinis, meliputi:
- b. tingkat kesadaran dan respons pasien;
- c. patensi jalan napas;
- d. frekuensi dan kualitas pernapasan;
- e. saturasi oksigen;
- f. tekanan darah;
- g. frekuensi dan irama jantung; dan
- h. parameter lain sesuai indikasi klinis.



3. Setelah Sedasi

Pasien harus tetap dipantau sampai memenuhi kriteria pemulihan yang telah ditetapkan.

Pemantauan meliputi:

- a. tingkat kesadaran;
- b. fungsi jalan napas dan pernapasan;
- c. kondisi kardiovaskular;
- d. saturasi oksigen;
- e. tanda-tanda vital;
- f. nyeri, mual, muntah, atau komplikasi lainnya; dan
- g. pemenuhan kriteria pemindahan atau pemulangan pasien.

Seluruh hasil penilaian dan pemantauan wajib didokumentasikan dalam rekam medis pasien.

H. TANGGUNG JAWAB DAN EVALUASI

1. Dokter pemberi sedasi bertanggung jawab atas penilaian pra-sedasi, perencanaan sedasi, pelaksanaan sedasi sesuai kewenangan, pemantauan, penanganan komplikasi, dan penilaian pemulihan pasien.
2. Pelaksanaan pelayanan sedasi wajib mengikuti pedoman pelayanan dan standar prosedur operasional yang berlaku di rumah sakit.
3. Kompetensi dan kewenangan dokter pemberi sedasi dievaluasi secara berkala melalui proses kredensial, rekredensial, evaluasi kinerja profesional, dan/atau mekanisme lain yang ditetapkan rumah sakit.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 14 Juli 2026

Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Resti Lestantini, M. Kes